Atendimento Odontológico à Pessoa com TEA

Cartilha de orientação para o cirurgião-dentista:
antes, durante e depois da consulta

Níveis de suporte 1 e 2



Para o consultório, a equipe e a família

Material educativo
Acompanha o card “Minha visita ao dentista”

Como usar esta cartilha

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem ter dificuldade com **imprevistos, barulhos, luzes, cheiros e toques**, além de se comunicarem de maneiras diferentes. No consultório, isso costuma gerar recusa, choro ou "fuga", não por birra, mas por **sobrecarga e falta de previsibilidade**. A boa notícia: com preparo simples, a consulta pode dar certo.

Este material mescla três recursos que funcionam bem com pessoas autistas, e vem em duas peças que trabalham juntas:





1. Esta cartilha (para o dentista)

O manejo passo a passo: o que fazer **antes** (preparo), **durante** (acolhimento e procedimento) e **depois** (reforço e continuidade). Fica no consultório, à mão de toda a equipe.



2. O card "Minha visita ao dentista"

Uma **história social ilustrada** em 10 passos, na voz do paciente. O dentista entrega ao cuidador, que lê com o paciente em casa, todos os dias, antes da consulta. Assim ele chega sabendo o que vai acontecer.

ANTES
Conhecer o paciente, preparar a família e o ambiente, entregar o card.

DURANTE
Acolher com calma, apresentar tudo (Falar–Mostrar–Fazer), respeitar o sinal de PARE.

DEPOIS
Recompensar, orientar a higiene em casa, registrar o que funcionou e marcar o retorno.

Regra de ouro: previsibilidade, uma coisa de cada vez e nunca forçar. Uma consulta em que o paciente apenas sentou na cadeira e saiu feliz é uma consulta que **deu certo**, porque a próxima será mais fácil.

O que você encontra aqui

3 · Antes da consulta: entrevista, vídeo, card, agenda e ambiente

4 · Durante, a chegada: acolhimento e Falar–Mostrar–Fazer

5 · Durante, o procedimento: degraus, sinal de PARE, sobrecarga

6 · Depois: brinde, higiene em casa, registro e retorno

7 · Informativo: o TEA no consultório, o que dizer e evitar

8 · Ficha do perfil do paciente e registro das consultas

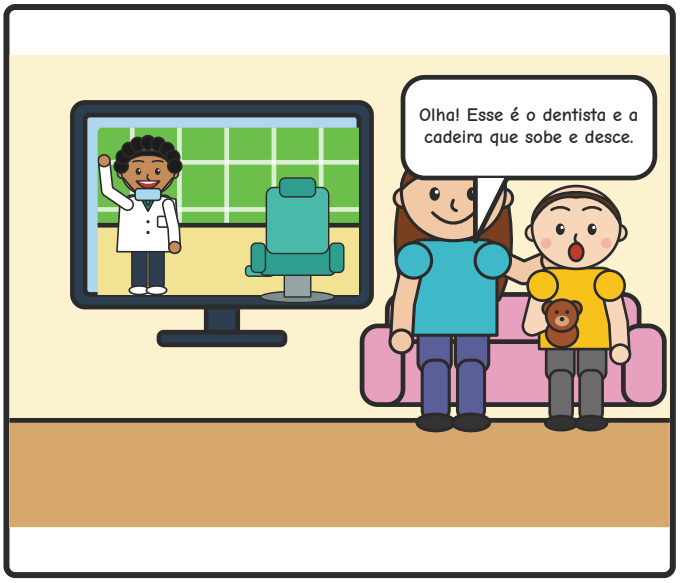
Os níveis de suporte 1 e 2 (DSM-5) indicam pessoas que precisam de apoio ou apoio substancial. Esta cartilha é educativa e não substitui a avaliação clínica individual nem a orientação da equipe multiprofissional que acompanha o paciente.

1 ANTES da consulta

Conhecer o paciente e preparar o caminho



1. Antes de marcar, o dentista conversa com quem cuida: como o paciente se comunica, o que o incomoda, o que ele adora.



2. A família recebe um vídeo curto do consultório e da equipe. Em casa, o paciente vê o que vai encontrar.

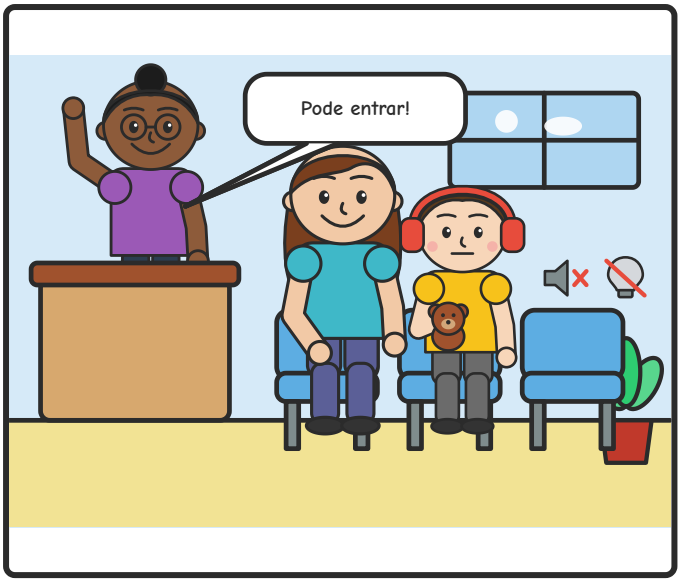
Checklist do ANTES

- **Entrevista prévia com pais ou cuidadores** (telefone, mensagem ou ficha da página 8): como se comunica (fala, figuras, gestos), sensibilidades (som, luz, cheiro, toque, texturas), interesses e reforçadores, gatilhos e sinais de desconforto, experiências anteriores, medicações e outras condições de saúde.
- **Envie vídeo ou fotos** do consultório, da equipe (sem máscara, para o rosto ser reconhecido) e dos equipamentos que farão barulho ou luz.
- **Entregue o card "Minha visita ao dentista"** para a família ler em casa, todos os dias, na semana da consulta. Peça que preencham o nome e a data.
- **Agende o primeiro horário** do turno ou o de menor movimento. Nada de espera longa; consulta curta (20 a 30 min).
- **Visita de ambientação**, se possível: só conhecer a sala, sentar na cadeira e ganhar um brinde. Sem procedimento.
- **Prepare o ambiente:** luz do refletor desligada até a hora, sem música ou TV alta, cheiros neutros, poucas pessoas na sala. Separe óculos escuros, fones abafadores e o brinde.
- **Combine com a família o sinal de PARE** (mão levantada) e um sinal de "tudo bem" (polegar). Eles também aparecem no card.

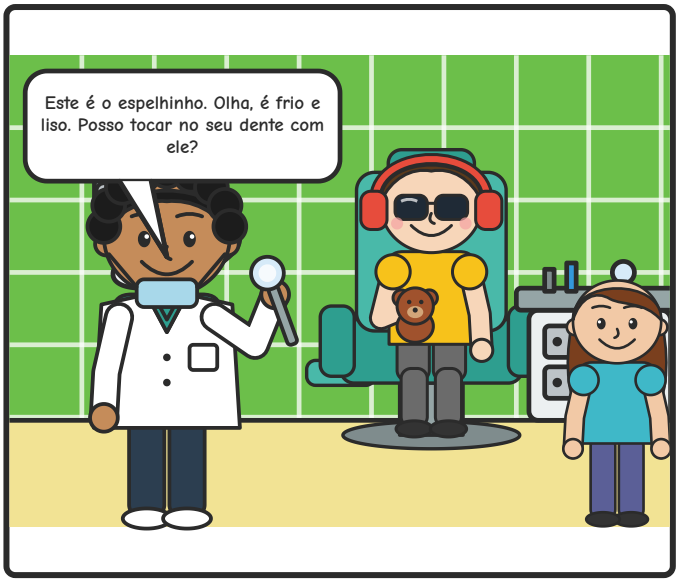
Use os interesses a favor: se o paciente adora dinossauros, o espelhinho vira o "explorador de dentes de dinossauro". O que a família contou na entrevista é o seu melhor instrumento.

2 DURANTE: a chegada

Acolher, apresentar e combinar



3. Sala de espera calma: pouca gente, sem TV alta, luz suave. O paciente pode ficar com seu objeto de conforto e os fones.



4. Falar–Mostrar–Fazer: o dentista explica, deixa tocar e só então usa cada instrumento. O acompanhante fica ao lado.

Como proceder no acolhimento

Chame pelo nome, com voz calma, na altura dos olhos. Não exija contato visual. Evite toques de surpresa (avise antes: “vou tocar no seu ombro”).

Acompanhante sempre na sala, de preferência onde o paciente possa vê-lo. Peça a ele que só intervenha se o dentista pedir, para não ter duas vozes ao mesmo tempo.

Falar–Mostrar–Fazer: apresente a cadeira, a luz, o espelhinho, o sugador (“o canudo que faz barulho”), o “chuveirinho”. Deixe tocar, ligue cada um longe da boca antes de usar.

Ofereça fones abafadores e óculos escuros. Ligue o refletor só depois dos óculos, e nunca direto nos olhos.

Linguagem clara e literal: frases curtas, uma instrução por vez, sempre na mesma ordem. Evite metáforas e ironia. Diga o que vai sentir (“vai fazer cócegas”, “vai ficar frio”), em vez de “não vai doer”.

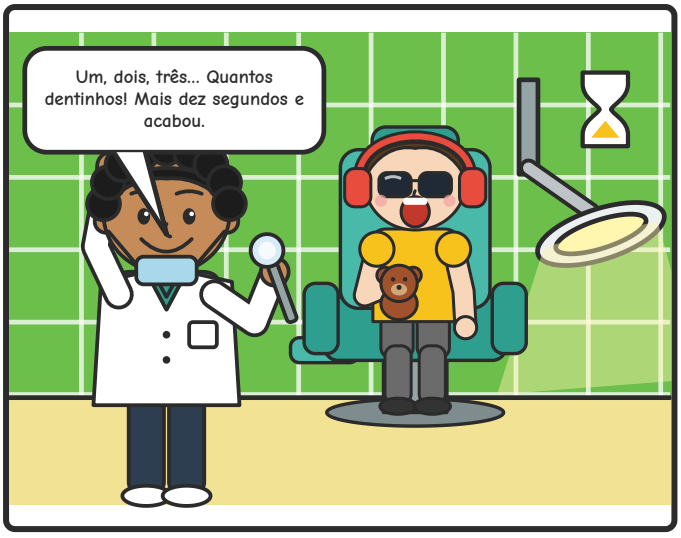
Dê previsibilidade: conte em voz alta (“até dez e paro”) ou use uma ampulheta. Avise cada etapa antes de começar e quando termina.

Cadeira: mova devagar, avisando (“vai subir”, “vai deitar um pouquinho”). Se ele não quiser deitar, atenda sentado.

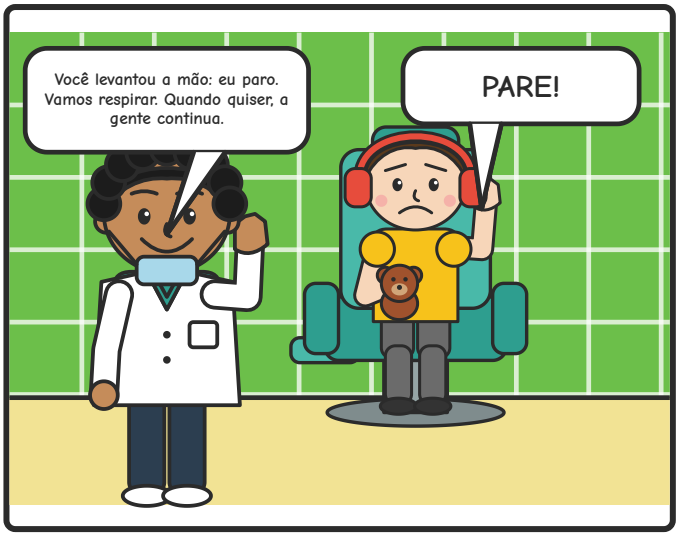
Mesma equipe, mesma sala, mesma sequência em todas as consultas. A repetição é o que transforma o consultório em um lugar seguro.

3 DURANTE: o procedimento

Pequenos passos, sinal de PARE e limites



5. Começa pelo mais simples: abrir a boca e contar os dentes, com contagem em voz alta. Depois, se der, a limpeza.



6. Mão levantada é PARE. O dentista para na hora, respira junto e só continua quando o paciente permitir.

Como proceder no procedimento

Dessensibilização gradual: sentar → abrir a boca → contar os dentes → escovação → flúor → profilaxia → restaurações simples. Avance um degrau por consulta e volte um se precisar.

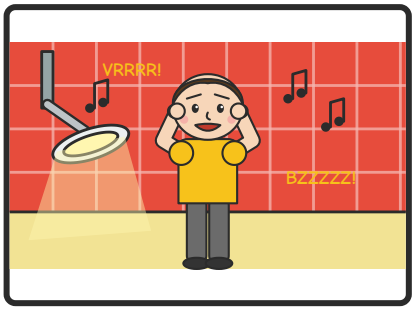
Respeite o sinal de PARE imediatamente, sempre. Pausas combinadas (“contamos até dez e paramos”) dão controle ao paciente.

Reforço positivo imediato e específico: “você abriu a boca bem grande!”. Elogie a tentativa, não só o resultado.

Nunca force nem segure o paciente. Estabilização protetora só com indicação clínica, consentimento da família e protocolo. Em caso de recusa, encerre de forma positiva e reagende.

Sinais de sobrecarga: tapar os ouvidos, balançar o corpo, gritar, chorar, morder, tentar sair. Ação: pare, reduza estímulos (luz, som, pessoas), ofereça o objeto de conforto, dê tempo.

Reduza o imprevisível: avise antes de ligar qualquer aparelho, apresente um instrumento por vez, sem conversas paralelas na sala.



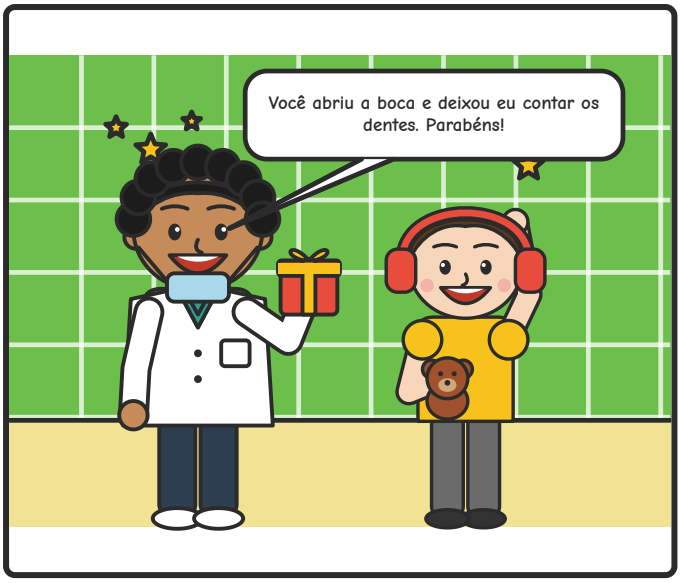
O que evitar: barulho súbito, luz forte no rosto, cheiros fortes, várias pessoas falando, toques sem aviso e “só mais um pouquinho” depois do PARE.

Meta do dia

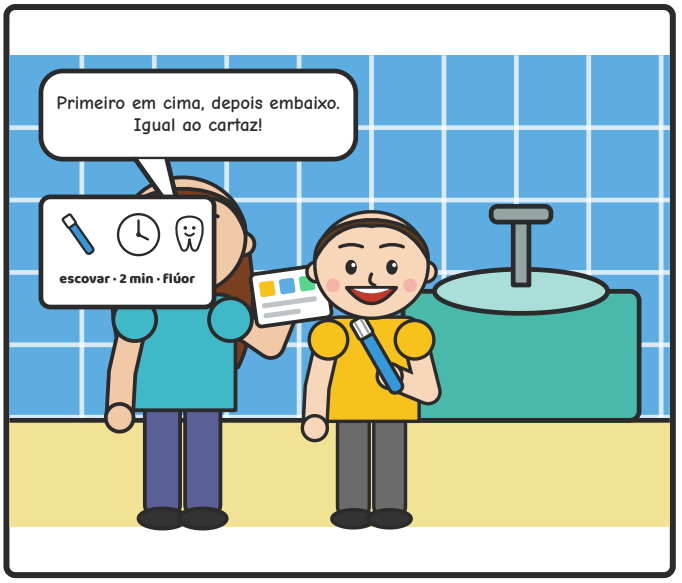
Defina com a família um objetivo pequeno e concreto (“hoje: contar os dentes”). Alcançou? A consulta foi um sucesso.

4 DEPOIS da consulta

Recompensar, orientar e dar continuidade



7. Terminou? Brinde e elogio específico, mesmo que só tenha sentado na cadeira. A consulta sempre acaba bem.



8. Em casa, a escovação segue uma rotina visual: mesma hora, mesma ordem, com apoio de figuras.

Como proceder depois

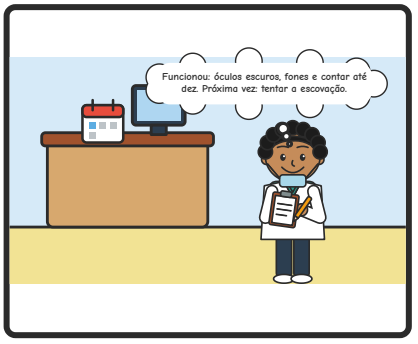
Encerre sempre de forma positiva: brinde, adesivo ou carimbo no card (“Eu consegui!”). Diga o que ele fez de bom e o que vai acontecer na próxima vez.

Orientações de higiene oral para casa: escovar 2x ao dia com rotina visual (figuras com a sequência), creme dental com flúor em sabor suave, escova macia (ou elétrica, se tolerar a vibração), fio dental com apoio do cuidador. Comece com poucos segundos e aumente aos poucos.

Registre o que funcionou e o que não funcionou (ficha da página 8): fones? óculos? contagem? música? Na próxima consulta, repita exatamente o que deu certo.

Marque o retorno antes de a família sair, em intervalo curto (30 a 90 dias). Consultas frequentes e curtas funcionam melhor do que raras e longas.

Converse com o cuidador sobre o próximo degrau, reforce o uso do card e combine o que praticar em casa (ex.: abrir a boca na frente do espelho, deixar contar os dentes com a escova).



9. O dentista anota o que funcionou. Na próxima consulta, a sequência se repete, e um novo passo é tentado.

Prevenção é tudo

Quanto menos cárie, menos procedimentos difíceis. Flúor, selantes e escovação orientada são os melhores aliados.

Informativo

O TEA no consultório, em poucas palavras

O autismo é um espectro: cada pessoa é única. Nos níveis de suporte 1 e 2, o paciente geralmente se comunica (com fala, figuras ou gestos) e consegue ser atendido no consultório comum, desde que haja preparo, previsibilidade e respeito ao ritmo dele. Quatro pontos mudam tudo:

- Sensorial: sons, luzes, cheiros, sabores e toques podem ser sentidos de forma muito intensa. Fones, óculos escuros, creme dental com sabor suave e avisos antes de tocar reduzem a sobrecarga.
- Comunicação: entendimento literal. Diga o que vai acontecer, em frases curtas, e mostre com figuras ou objetos. Pergunte à família como ele diz "sim", "não" e "dor".
- Previsibilidade: mudanças geram ansiedade. Mesma equipe, mesma sala, mesma sequência, e o card lido em casa antes.
- Interesses intensos: são aliados. Use o tema favorito para explicar e para recompensar.

O que dizer e o que evitar

Evite	Prefira
"Não vai doer nada."	"Você vai sentir frio e cócegas. Eu aviso antes."
"Abre a boca que eu vou dar uma olhadinha rapidinho."	"Abre a boca. Vou contar seus dentes até dez. Um, dois..."
"Se não deixar, vai ter que tomar injeção."	"Quando você levantar a mão, eu paro. Combinado?"
Vários profissionais falando ao mesmo tempo.	Uma voz só, calma, sempre a mesma pessoa.
Ligar o motor ou a luz de surpresa.	"Agora vou ligar o canudo que faz barulho. Ouve primeiro."
Segurar, insistir ou negociar "só mais um pouquinho".	Parar, respirar, reduzir estímulos e, se preciso, encerrar bem e remarcar.

Sinais de sobrecarga sensorial

Tapar os ouvidos, fechar os olhos com força, balançar o corpo, repetir frases, chorar, gritar, morder, tentar sair da cadeira ou "desligar" (ficar imóvel e sem responder). Diante deles: pare, diminua luz e som, ofereça o objeto de conforto e dê tempo. Retomar só se o paciente sinalizar que está pronto.

Sinais combinados (iguais aos do card)



Mão levantada
PARE



Pausa
quero descansar



Polegar
tudo bem, pode continuar

Referências de base: Falar–Mostrar–Fazer (tell-show-do), dessensibilização sistemática, histórias sociais, apoio visual (PECS) e reforço positivo, recomendados na odontopediatria e na odontologia para pacientes com necessidades especiais.

Ficha: perfil do paciente com TEA

Preencha com a família na entrevista prévia e atualize após cada consulta. Guarde no prontuário.

Nome: _____ **Idade:** _____

Responsável: _____ **Telefone:** _____

Nível de suporte: ☐ 1 ☐ 2 **Outras condições / medicações:** _____

Comunicação

☐ Fala ☐ Figuras (PECS) ☐ Gestos ☐ Tablet

Como diz “sim” / “não” / “dor”: _____

Sensibilidades (marque o que incomoda)

☐ Sons altos ☐ Luz forte ☐ Cheiros ☐ Toque no rosto

☐ Sabores / texturas ☐ Água na boca ☐ Deitar

Outros: _____

Interesses e reforçadores

Gosta de: _____

Brinde que funciona: _____

Objeto de conforto: _____

Gatilhos e sinais de desconforto

O que desencadeia crise: _____

Como demonstra desconforto: _____

O que acalma: _____

Experiências anteriores no dentista

☐ Nunca foi ☐ Foi bem ☐ Foi difícil

Observações: _____

Apoios combinados

☐ Fones ☐ Óculos escuros ☐ Contagem ☐ Ampulheta

☐ Card lido em casa ☐ Vídeo enviado ☐ Visita de ambientação

Sinal de PARE combinado: _____

Registro das consultas

Data	Até onde chegou (degrau)	O que funcionou	Próximo passo

Sobre este material. Cartilha educativa para cirurgiões-dentistas e equipes de saúde bucal sobre o atendimento de pessoas com TEA (níveis de suporte 1 e 2). Inspirada no formato das HQs educativas de higiene bucal. Ilustrações vetoriais originais. Pode ser reproduzida gratuitamente para fins educativos, com citação da fonte.
Concepção e roteiro: _____ **Revisão técnica:** _____ **Edição:** 1ª · _____ / _____